



Cour des comptes



Fonds des accidents médicaux – Organisation et fonctionnement

Suivi 2025 des recommandations



Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, novembre 2025



Cour des comptes

Fonds des accidents médicaux – Organisation et fonctionnement

Suivi 2025 des recommandations



Rapport adopté le 19 novembre 2025 par l'assemblée générale de la Cour des comptes

1	Contexte	3
2	Audit initial de 2020	4
3	Évolution après l'audit	5
4	Méthode de suivi	6
5	Mise en œuvre des recommandations	6
6	Conclusions	22

Fonds des accidents médicaux – Organisation et fonctionnement : suivi 2025 des recommandations

Le Fonds des accidents médicaux (ci-après le « Fonds ») a été créé par la loi du 31 mars 2010 (« loi relative aux accidents médicaux ») pour rendre aux victimes d'accidents médicaux un avis, au terme d'un examen médical et juridique, concernant la responsabilité éventuelle d'un prestataire de soins dans un accident et leur fournir certaines garanties quant à l'indemnisation effective du dommage. Par cette procédure administrative, le législateur entendait régler les accidents médicaux plus rapidement, plus simplement, à moindre coût et plus efficacement que dans le cadre d'une procédure judiciaire. En outre, le Fonds pourrait formuler des recommandations pour mieux prévenir les accidents médicaux sur la base des dossiers de sinistre.

Dans son rapport de juin 2020, la Cour des comptes examinait l'organisation et le fonctionnement du Fonds. La Cour constatait que peu de victimes faisaient appel à lui, principalement à cause des délais de traitement très longs et de la faible probabilité d'indemnisation. Elle relevait également que certaines missions n'étaient pas réalisées et que les frais de fonctionnement étaient élevés. Dans un premier temps, elle demandait de reconsidérer la pertinence de la loi relative aux accidents médicaux et le rôle du Fonds. Elle formulait en outre des recommandations afin d'adapter certains processus.

Dans le cadre de son suivi de 2025, la Cour des comptes a examiné si les recommandations formulées en 2020 ont été suivies. La Cour conclut que, sur les 24 recommandations, 11 ont été mises en œuvre et 12 sont en cours de réalisation. Une recommandation n'a pas été mise en œuvre.

Le suivi montre également que le plan d'action mis en place par le Fonds a permis de combler son retard dans le traitement des dossiers. Ce mouvement de rattrapage a toutefois eu pour conséquence que le délai de traitement pour les avis a augmenté temporairement et n'a diminué progressivement que ces dernières années. La vigilance reste donc de mise. En outre, le Fonds doit continuer à s'investir dans des missions qui ne sont pas encore menées suffisamment à bien. Vu son coût de fonctionnement élevé, la Cour des comptes estime qu'il reste pertinent d'évaluer la législation ainsi que le rôle du Fonds.

1 Contexte

La loi relative aux accidents médicaux accorde à la victime d'un accident médical le droit d'obtenir un avis (gratuit) sur la responsabilité éventuelle d'un prestataire de soins dans l'accident et garantit, dans certains cas, l'indemnisation effective du dommage. Ces interventions sont versées par le Fonds, créé par la même loi. Le Fonds est un service autonome de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami). Il indemnise lui-même la victime dans les cas suivants :

- Si l'avis fait état d'un **accident médical avec responsabilité**, le Fonds indemnise le dommage lorsque le prestataire de soins n'est pas ou pas suffisamment assuré, lorsque l'assureur formule une offre d'indemnisation manifestement insuffisante ou lorsque l'assureur ne se range pas à

l'avis et conteste la responsabilité du prestataire de soins. Dans ce dernier cas, le Fonds n'indemnise le dommage que lorsqu'il dépasse un certain « degré de gravité »¹.

- Si l'avis fait état d'un **accident médical sans responsabilité**, le Fonds prend à sa charge l'indemnisation du dommage dans des circonstances plutôt exceptionnelles, à savoir lorsque le dommage remplit le critère de gravité précité, mais est en outre de nature « anormale »².

En instaurant l'intervention du Fonds, le législateur visait un règlement des accidents médicaux plus rapide, plus simple, à moindre coût et plus efficace que dans le cadre d'une procédure judiciaire, tant dans l'intérêt des victimes que des prestataires de soins. En raison des critiques croissantes quant à la gestion trop lente des dossiers par le Fonds et de l'absence d'amélioration malgré l'intervention de consultants, la Cour des comptes a décidé fin 2018 de lancer un audit³.

2 Audit initial de 2020

Dans son audit initial, publié le 3 juin 2020⁴, la Cour des comptes avait évalué le degré de réalisation de ces objectifs 10 ans après la création du Fonds. La Cour avait constaté que, selon les estimations, 9 victimes sur 10 ne faisaient pas usage des droits que leur offrait cette procédure administrative pourtant accessible, mais qu'elles s'adressaient plutôt directement au prestataire de soins et à son assureur dans le cadre d'une procédure à l'amiable ou d'une procédure judiciaire.

Cette situation s'expliquait par la lenteur de la procédure (en moyenne 4 ans pour obtenir un avis, suivis d'au moins 18 mois pour l'indemnisation) et par la probabilité faible d'être indemnisé. En effet, le Fonds ne garantit pas d'indemnisation en cas d'avis en matière de responsabilité sous le seuil de gravité. Le nombre limité de demandes d'intervention (alors inférieur à 500 par an) avait, à son tour, pour effet que la masse critique nécessaire pour faire de la prévention n'était pas atteinte. Ce nombre limité de dossiers ainsi que le faible taux d'indemnisation mettent en cause la raison d'être même du Fonds, sous sa forme actuelle en tout cas et à la lumière des frais de fonctionnement élevés (alors estimés à 12.000 euros en moyenne par dossier ouvert).

Bien que la Cour des comptes ait formulé dans son rapport initial une série de recommandations concernant la gestion du Fonds et la gestion des dossiers, elle a surtout souligné l'importance d'une approche plus fondamentale à long terme. Pour la Cour, la pertinence de la loi relative aux accidents médicaux ainsi que le rôle du Fonds devaient être réexaminés.

1 Il doit s'agir d'un décès, d'une invalidité permanente d'au moins 25 %, d'une incapacité temporaire de travail d'au moins 6 mois sur une période d'un an ou de perturbations particulièrement graves des conditions de vie. En cas d'accident médical avec responsabilité, le Fonds récupère les indemnités versées auprès du prestataire de soins jugé responsable ou auprès de son assureur.

2 Le dommage est considéré comme anormal lorsqu'il n'aurait pas dû se produire compte tenu de l'état actuel de la science, de l'état du patient et de son évolution objectivement prévisible.

3 Étant donné que le Fonds avait annoncé de nouvelles initiatives qui allaient modifier son fonctionnement, le début des travaux d'audit a été reporté de six mois. Les effets de ces mesures, notamment la désignation d'un consultant externe et de nouveaux coordinateurs, ont ainsi pu être examinés eux aussi.

4 Cour des comptes, *Fonds des accidents médicaux – Organisation et fonctionnement*, rapport à la Chambre des représentants, Bruxelles, juin 2020, 94 p., [courdescomptes.be](https://www.courdescomptes.be).

3 Évolution après l'audit

Sous l'impulsion du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, un plan d'action a été élaboré au premier semestre de 2021. Ce plan englobait, d'une part, une adaptation structurelle du traitement des dossiers (devant permettre une accélération du traitement) et, d'autre part, le recours à une task force spéciale afin de rattraper en partie le retard des dossiers en 2 ans (voir la [recommandation 3](#)). Ce plan n'insistait pas sur une évaluation ou une adaptation poussée de la loi relative aux accidents médicaux, ni sur le rôle du Fonds⁵.

Fin octobre 2023, la task force avait finalement traité 1.249 dossiers, dont 83 % ont été clôturés par un avis. Combinés aux dossiers clôturés par l'équipe de base du Fonds, cela représentait une diminution importante du retard (passage de 2.445 dossiers ouverts fin 2019 à 1.066 fin 2023 et même 989 fin 2024⁶). Pour le suivi des délais de traitement, le Fonds utilise un indicateur qui calcule, par année, le nombre de mois nécessaire pour clôturer 80 % des dossiers ouverts cette année-là. Pour les dossiers ouverts en 2022⁷, ce délai était de 13,2 mois, tandis que, pour les dossiers ouverts en 2019, il était encore de 31,6 mois. L'augmentation du nombre de dossiers clôturés a également entraîné une augmentation des indemnisations versées. Alors que le Fonds avait versé 16,3 millions d'euros entre sa création et fin 2018, ce montant est passé à 101,1 millions d'euros fin 2024⁸.

Le recours à la task force a également entraîné une hausse du coût. Alors que le coût total hors indemnisations s'élevait à 6,4 millions d'euros fin 2018, il est passé à 12,4 millions d'euros en 2023. En parallèle, le nombre d'avis (651 en 2023 contre 517 en 2018) et de dossiers clôturés (735 en 2023 contre 616 en 2018) a légèrement augmenté. Le Fonds a repris au sein de l'équipe de base une partie du personnel de la task force arrivée au terme de sa mission et souhaite même maintenir un cadre de 62 personnes (voir la [recommandation 4](#)). En outre, il est confronté à une augmentation des coûts juridiques à la suite des procédures de récupération vis-à-vis des assureurs et des procédures de contestation d'un avis ou d'une indemnisation du Fonds par les victimes. Par conséquent, le coût reste élevé.

Fin 2024, le coût total hors indemnisations s'élevait à 12,5 millions d'euros, pour 590 avis et 681 dossiers clôturés cette année-là⁹. Par conséquent, la recommandation de la Cour des comptes concernant l'évaluation de la loi relative aux accidents médicaux et la réévaluation du rôle du Fonds reste d'actualité, d'autant que certaines missions (comme la prévention) bénéficient encore de trop peu d'attention.

5 La loi relative aux accidents médicaux a toutefois été modifiée afin de désormais permettre au Fonds d'utiliser également un formulaire de demande numérique et d'envoyer des recommandés électroniques. Une nouvelle disposition détermine également qu'un demandeur qui conteste une décision de non-indemnisation par le Fonds peut intenter, dans l'année qui suit l'avis, une action contre le Fonds devant le tribunal de première instance.

6 Un nombre approximatif de 1.000 dossiers en cours était attendu, compte tenu du nombre de dossiers qui entrent chaque année (par exemple, 632 en 2024), du temps de traitement actuel et des dossiers qui ne peuvent pas être clôturés en raison d'un litige.

7 Lorsque la Cour des comptes a terminé son suivi en août 2025, le seuil de 80 % des dossiers ouverts en 2023 n'avait pas encore été atteint.

8 Calculé sur la base des rapports d'activité du Fonds.

9 En divisant le coût de 2024 (12,5 millions d'euros) par le nombre moyen de dossiers que le Fonds a clôturés au cours de la période 2021-2024 (760), les coûts d'un dossier s'élèvent à environ 16.500 euros. En l'absence de comptabilité des coûts, ce montant ne représente qu'une estimation générale brute sans distinction entre les différentes phases d'un dossier et sans tenir compte d'autres missions du Fonds (comme la prévention).

De plus, l'élaboration d'avis avec responsabilité sous le seuil de gravité est chronophage, alors que le Fonds n'indemnise pas le dommage et que l'assureur n'est pas tenu de suivre l'avis. Une analyse plus poussée de la loi relative aux accidents médicaux a toutefois bien été prévue, mais sans intention de la modifier dans le cadre d'une nouvelle optimisation du fonctionnement du Fonds. Un tel exercice ne serait pourtant pas contraire à la garantie d'un fonctionnement fluide, transparent et correct du Fonds conformément à l'accord de coalition fédérale 2025-2029.

4 Méthode de suivi

Comme mentionné ci-avant, la Cour des comptes avait formulé des recommandations visant à améliorer le fonctionnement du Fonds dans son audit initial. Dans ce suivi, la Cour a examiné auprès du Fonds dans quelle mesure les recommandations ont été mises en œuvre et pourquoi aucune suite n'a été donnée à certaines d'entre elles. À cet effet, elle s'est basée sur les documents en accès public, les déclarations du Fonds et les documents transmis pour les étayer. La Cour n'a pas mené de travaux d'audit (tels que des entretiens, tests et analyses approfondies des documents et données) pour apprécier la qualité des informations reçues et évaluer les mesures mises en place.

La Cour des comptes a évalué la mise en œuvre de chaque recommandation ainsi que les modalités de cette mise en œuvre. Elle lui a attribué un code en fonction de son avancement.

	Mise en œuvre complète
	Mise en œuvre en cours
	Absence de mise en œuvre

Un projet de rapport a été transmis pour commentaire au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au Fonds et à l'Inami. Le ministre et l'Inami renvoient à la réponse du Fonds, dont il a été tenu compte au besoin dans ce rapport.

5 Mise en œuvre des recommandations

Recommandation 1 Continuer à veiller à l'autonomie nécessaire du Fonds à l'égard de l'Inami et délimiter les compétences, mais aussi éventuellement les responsabilités plus concrètement dans le règlement d'ordre intérieur	Fonds	
---	-------	---

Le Fonds agit comme un service spécial de l'Inami. Étant donné qu'il influe sur les dépenses de l'assurance maladie et doit disposer de moyens suffisants pour accomplir ses missions, le Fonds doit bénéficier d'une certaine autonomie par rapport à l'Inami. Le Fonds indique que son comité de direction est chargé en premier lieu d'assurer son indépendance dans l'exécution de ses missions. Le Fonds gère ses propres processus et fonctionne sous la supervision de son propre comité de gestion et d'un commissaire du gouvernement.

Ce n'est qu'en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires (par exemple dans le cadre de la sélection de projets d'automatisation, de la définition du cadre du personnel, du

lancement d'un marché public, etc.) que le comité de gestion général de l'Inami a également un rôle à jouer. La Cour des comptes n'a pas constaté de manquements en la matière par le passé¹⁰.

Étant donné que le législateur avait aussi prévu des garanties pour éviter que l'Inami ne s'immisce dans la gestion des dossiers individuels par le Fonds¹¹, la Cour des comptes conclut que la mise en œuvre de cette recommandation est suffisamment garantie.

Recommandation 2

Soutenir au maximum le rôle des nouveaux coordinateurs ; leur donner la marge de manœuvre pour redéfinir les processus de travail et les moyens pour suivre ceux-ci, également dans l'intérêt du rétablissement de la dynamique du service

Fonds



Le Fonds a une structure d'organisation transparente. Sous l'autorité de la direction, trois départements sont chacun soumis à un coordinateur¹² et sont responsables de la gestion administrative des dossiers, des analyses médicales et du traitement juridique (rédaction d'avis, détermination d'indemnités et gestion de litiges). Cette structure correspond aux trois phases par lesquelles passe chaque dossier dans le cadre du traitement d'un accident médical. Un secrétariat et un service d'appui (expert financier et juridique et coordinateurs TIC) soutiennent la direction et les départements. Le directeur, les coordinateurs et les membres du service d'appui se réunissent chaque semaine. Une réunion TIC spécifique a également lieu toutes les deux semaines.

Chaque département est responsable de l'adaptation, de l'harmonisation et de la documentation¹³ de ses processus de travail et de la communication d'éventuelles modifications aux collaborateurs. L'usage de l'informatique est encouragé autant que possible. À cet effet, le Fonds renvoie aux mises à jour régulières de Damo¹⁴ et d'Eunom-e¹⁵ ainsi qu'aux manuels actualisés.

En ce qui concerne le suivi, le Fonds fait essentiellement référence à la gestion et à l'enregistrement de tâches dans Damo et à l'utilisation d'un entrepôt de données (*datawarehouse*) et de Power BI pour permettre à la direction de suivre certains indicateurs dans un tableau de bord. La Cour des comptes estime important de poursuivre dans cette direction pour que les problèmes puissent être détectés rapidement et les prestations (des départements, collaborateurs, etc.) suivies à l'aide d'indicateurs. Le nouveau contrat d'administration de l'Inami reprend également des engagements en ce sens (voir la **recommandation 3**), même si le Fonds reste dans l'attente des budgets nécessaires au recrutement d'un gestionnaire de données. Cette recommandation reçoit dès lors le statut de mise en œuvre en cours, notamment pour cette raison.

¹⁰ À l'inverse, le Fonds a reçu des moyens supplémentaires en 2021 (notamment la task force) pour rattraper les retards.

¹¹ L'article 137ter de la loi relative à l'assurance maladie dispose que tous les collaborateurs du Fonds sont tenus au secret professionnel et qu'aucun autre service de l'Inami « ne peut demander ou avoir accès ou recevoir une information sur des dossiers et affaires individuelles ou des personnes concernées par ceux-ci et traités par le service, même pour ou dans le cadre de l'exercice des missions de cet autre service ».

¹² Pour la gestion administrative, le département est scindé en deux sections (francophone et néerlandophone), ayant chacune un coordinateur.

¹³ Le Fonds a également repris la description des processus dans une application d'appui spécifique (Hopex) à l'Inami.

¹⁴ Damo (dossiers Accidents médicaux / *Medische Ongevallen*) est un système de gestion qui vise à fournir les données nécessaires au pilotage ciblé du fonctionnement quotidien du Fonds (par exemple, au niveau des délais de traitement).

¹⁵ Eunom-e est une application de gestion des litiges juridiques, utilisée au sein de l'Inami.

Recommandation 3

Sur la base d'une note de vision solide, élaborer un plan stratégique et opérationnel et utiliser entre-temps des objectifs concrets simples, tels que des délais indicatifs pour certains processus de travail

Fonds



En premier lieu, il peut être fait référence au plan d'action Adaptation structurelle et résorption du retard¹⁶, examiné lors du comité de gestion du 2 avril 2021. Par ce plan, le Fonds visait à prendre à bras-le-corps les problèmes fondamentaux auxquels il était confronté et à briser définitivement le cercle vicieux des retards accumulés dans les dossiers et des très longs délais de traitement. Le plan comporte deux volets, réalisables sans modifier la loi relative aux accidents médicaux.

- Le premier volet prévoyait une adaptation structurelle du traitement des dossiers grâce à une approche plus proactive basée sur une collecte plus rapide des pièces (médicales) par l'intermédiaire du demandeur. Le plan spécifie aussi que l'analyse médicale interne détermine la suite de la procédure en fonction du seuil de gravité et des indications de responsabilité (voir la [recommandation 18](#)).
- Le second volet prévoit le déploiement d'une task force dotée d'effectifs supplémentaires pour résorber le retard (initialement 1.300 dossiers) sur 2 ans.

Par ailleurs, l'intention est également de poursuivre l'informatisation du Fonds (extension des fonctionnalités dans Damo et déploiement d'une nouvelle version, migration vers une plate-forme *Case Management* plus performante, etc.).

La mise en œuvre du plan d'action a été reprise dans le contrat d'administration 2022-2025 de l'Inami¹⁷.

- Concernant le premier volet, le Fonds était tenu de développer pour le 31 janvier 2023 des tableaux de bord contenant les indicateurs clés pour le suivi du fonctionnement quotidien et régulier du Fonds. Le Fonds a bien commencé à les élaborer (voir la [recommandation 2](#)), mais a attendu le recrutement d'un gestionnaire de données pour les affiner. Par ailleurs, le Fonds devait également définir des objectifs de prestation pour le traitement des dossiers pour le 31 décembre 2024. Le rapportage 2023 relatif à l'exécution du contrat d'administration indiquait que l'action était en cours.
- Concernant le second volet, le Fonds devait avoir résorbé l'arriéré pour le 30 septembre 2023 et exposer la situation au comité de gestion tous les trois mois. La mission de la task force s'est terminée fin octobre 2023. À ce moment-là, 83 % des 1.249 dossiers ouverts qui lui avaient été confiés étaient clôturés par un avis. S'agissant des dossiers restants, l'avis n'avait pas encore été rendu dans 16 % des cas (13 % des dossiers faisaient encore l'objet d'une expertise externe et 3 % étaient en traitement par le Fonds) et 1 % des dossiers était « en attente » à la requête du demandeur (dans le cas de discussions en cours avec l'assureur concernant un règlement à l'amiable, par exemple)¹⁸.

Dans le cadre du nouveau contrat d'administration de l'Inami, le Fonds vise un équilibre stable entre ses différentes missions, en donnant toutefois la priorité à la gestion de demandes indivi-

¹⁶ Inami, *Plan d'action 2021 du Fonds des accidents médicaux : adaptation structurelle et élimination du retard*, www.inami.fgov.be.

¹⁷ Inami, *Sixième contrat d'administration 2022-2025 entre l'État et l'Institut national d'assurance maladie invalidité (Inami)*, www.inami.fgov.be.

¹⁸ Inami, *Bilan du plan d'action et de la task force du Fonds des accidents médicaux : retards résorbés et délais de traitement raccourcis*, www.inami.fgov.be.

duelles (formulation d'avis, détermination d'indemnités et suivi de litiges). De même, les paramètres de qualité, de quantité et des délais sont évalués de manière équilibrée. À cet effet, un outil spécifique devait être développé après la désignation d'un gestionnaire de données pour mettre en évidence l'effet de chaque dossier entrant sur l'ensemble du processus de traitement. En outre, il était prévu que le Fonds poursuive l'identification des dispositions de la loi relative aux accidents médicaux qui sont à revoir et prépare les modifications nécessaires.

Tous ces éléments indiquent que, à la suite de l'audit initial de la Cour des comptes, un plan a été élaboré qui offre essentiellement une solution aux problèmes fondamentaux. Après la clôture des travaux de la task force et l'expiration fin 2025 du contrat d'administration liant l'Inami à l'État, la priorité continuera d'être donnée à l'affinement des processus de gestion existants. La Cour considère dès lors que cette recommandation est en cours de mise en œuvre.

Recommandation 4

Évaluer la taille et la composition nécessaires de l'effectif en fonction de la vision d'avenir du rôle du Fonds ; veiller entre-temps à conserver le savoir-faire et la continuité au niveau du fonctionnement

Fonds



Les données du Fonds (voir le [tableau 1](#)) montrent que l'effectif a fortement augmenté entre 2018 et 2021 (respectivement de 48 et 50 %) tant en nombre qu'en termes d'ETP. Cette augmentation s'explique principalement par la reprise de collaborateurs initialement recrutés à titre temporaire pour constituer la task force dans l'équipe de base à la fin de leurs travaux en 2023. Cette reprise n'a toutefois pas empêché une nouvelle diminution de l'effectif depuis 2021¹⁹.

L'adaptation du cadre légal à la situation sur le terrain a quelque peu tardé. L'extension de l'effectif pour le lancement de la task force n'a ainsi été prise en compte que dans le plan de personnel de 2022. Un plan de personnel n'a pas été établi pour 2023, mais bien pour 2024. Selon le Fonds, un cadre de 62 personnes était initialement prévu pour 2025, comprenant un expert-juriste (A3) et un gestionnaire de données. La rédaction du plan de personnel de 2025 a toutefois été suspendue dans l'attente de la formation du gouvernement fédéral. Dans l'intervalle, de nouvelles économies ont été imposées, nécessitant le report des nouveaux recrutements demandés.

Les actions du Fonds indiquent que celui-ci évalue régulièrement son effectif et essaie de recruter l'expertise nécessaire. La recommandation est dès lors considérée comme mise en œuvre. Une remarque est toutefois formulée en marge concernant la disponibilité du personnel. Les chiffres communiqués concernant les prestations, qui tiennent compte selon le Fonds de toutes les absences²⁰, font état d'un taux d'absence élevé. La Cour des comptes recommande d'améliorer le suivi de ces absences et d'entreprendre des actions supplémentaires si nécessaire²¹.

¹⁹ Entre 2018 et 2024, près de 5 ETP ont quitté l'équipe de base du Fonds chaque année.

²⁰ Tous les régimes à temps partiel, les jours de vacances légales, les interruptions de carrière, les congés de maladie ou de maternité, etc., seraient inclus dans ce calcul. Lorsqu'il n'est pas tenu compte des absences pour raisons personnelles, stage ou interruption de carrière complète (par exemple, 4 ETP en 2024 selon le Fonds) que ces chiffres devraient englober, les absences restent assez élevées.

²¹ Sur la base d'un rapport de l'Inami concernant les risques psychosociaux, certaines mesures ont toutefois été prises principalement pour améliorer la communication avec le personnel, comme le développement d'un intranet, l'organisation de davantage de moments de rencontre formels et informels (réunion stratégique, rencontre lors d'une prestation de serment, formations communes, etc.) et la possibilité de suivre des formations externes.

Tableau 1 – Évolution de l'effectif 2018-2024 (jusqu'au 16 décembre 2024)

Année	Cadre	Nombre	ETP	Prestation	Prestation/ ETP
2018 ²²	50	42	38,4	19,3	50,2 %
2019	57	51	48,7	27,7	56,9 %
2020	57	54	43,3	25,9	59,8 %
2021	54	62	50,7	31,1	61,3 %
2022	68	58	51,8	30,2	58,2 %
2023	68	57	50,5	29,7	58,8 %
2024	57	56	49,3	28,4	57,6 %

Source : Fonds des accidents médicaux

Recommandation 5

Décider si la réglementation relative aux recettes doit être adaptée en fonction de la pratique actuelle et veiller à un rapportage cohérent au sujet des dépenses et à une transparence accrue concernant les coûts et les indemnités

Fonds



Dans son audit initial, la Cour des comptes avait observé que le préfinancement prévu par l'Inami n'avait pas lieu dans les faits. En effet, le Fonds n'ayant pas de comptes financiers propres, toutes ses opérations financières sont effectuées par l'Inami. L'arrêté royal qui fixe le montant à charge des frais d'administration de l'Inami destiné au financement du Fonds n'est donc plus nécessaire. Il n'est d'ailleurs plus rédigé depuis l'exercice 2023.

En ce qui concerne le rapportage, le Fonds mentionne dans son budget et ses comptes également les recettes propres sur la base du principe des droits acquis. Elle doit toutefois attendre que le projet Droits constatés de l'Inami soit finalisé pour le suivi des créances. S'agissant des dépenses, un rapportage distinct est prévu dans les comptes concernant les différents postes de dépenses (indemnités, expertises médicales, aide juridique, etc.). Les estimations de dépenses ne reposent plus sur les estimations du Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), mais sur des données propres, ce qui est positif et reflète mieux la réalité.

À la demande du comité de gestion, une plus grande attention a également été portée aux futures indemnités « lourdes ». Le Fonds identifie désormais ainsi aussi les dossiers dans lesquels l'indemnité peut avoir une incidence significative sur les missions du Fonds. Des montants distincts sont estimés à cet effet. Il reste cependant primordial que le Fonds comptabilise les provisions nécessaires.

Vu les améliorations requises pour le suivi comptable des créances et des dépenses futures, la Cour des comptes attribue le statut de mise en œuvre en cours à cette recommandation.

²² Les écarts avec les chiffres 2018 du rapport initial de la Cour des comptes (43 collaborateurs qui correspondent à 39,9 ETP, dont 31,8 réellement disponibles) n'ont pas été examinés.

Recommandation 6

Veiller d'urgence à l'enregistrement et au suivi des indemnités et coûts à recouvrer et fixer une politique claire à ce sujet, notamment concernant l'abandon éventuel de droits à recouvrement

Fonds
Inami



Dans son audit initial, la Cour des comptes avait attiré l'attention sur l'absence d'instructions concernant l'enregistrement et le suivi de montants que le Fonds doit récupérer auprès des prestataires de soins et des assureurs. Il en va de même pour la procédure à suivre pour renoncer au recouvrement. La Cour avait évoqué une possible intervention du comité de gestion en la matière.

Dans sa réponse, le Fonds indique récupérer systématiquement, auprès du prestataire de soins ou de l'assureur, les indemnités versées en cas d'accident médical avec responsabilité au-dessus du seuil de gravité, sauf dans de rares exceptions (par exemple, lorsque le prestataire de soins non assuré est décédé, n'a plus de résidence en Belgique ou est considéré comme insolvable). Depuis 2023, les décisions de renonciation au recouvrement sont également soumises au comité de gestion chaque année.

Le Fonds ne récupère toutefois pas les frais d'expertise d'un avis en cas d'accident médical avec responsabilité sous le seuil de gravité ou d'indemnisation par l'assureur²³. Cette décision repose sur une analyse coût-bénéfice : ces frais d'expertise à récupérer doivent être mis en balance avec d'éventuels frais de justice.

La Cour des comptes observe une augmentation du nombre de récupérations auprès de l'assureur et de leur montant. Alors que la Cour des comptes soulignait qu'à peine 39.423 euros d'indemnités versées avaient été récupérés dans deux dossiers fin 2018²⁴, ce montant est passé à 3.792.737,20 euros fin 2024²⁵. Toutefois, il ne s'agit que de 17 % des 22.943.229,41 euros d'indemnités versées au total jusque fin 2024 pour des accidents médicaux avec responsabilité au-dessus du seuil de gravité. Il est difficile de déterminer dans quelle mesure le solde fait encore l'objet d'un litige en cours ou n'est plus recouvrable²⁶.

Le même problème se pose pour les frais de justice et les divers honoraires payés (notamment les frais d'expertise). Le Fonds indique le montant récupéré chaque année, mais ne précise pas le montant qui aurait dû être récupéré. Le Fonds a toutefois fait référence à un projet de l'Inami, où les montants à récupérer d'ici fin 2026 seraient effectivement suivis, par redevable, dans une comptabilité (voir la [recommandation 5](#)). Dans l'intervalle, le Fonds aurait l'intention d'intégrer dans l'application Damo les informations concernant les indemnités versées, les condamnations judiciaires, les récupérations et les paiements.

Vu les améliorations encore à réaliser, cette recommandation reçoit le statut de mise en œuvre en cours.

²³ Le Fonds demande à l'assureur une copie de l'offre d'indemnisation. Après réception, le dossier est clôturé. Ce dossier est également clôturé après un rappel resté sans réaction. Dans ce cas, l'assureur est présumé contester la responsabilité de son assuré.

²⁴ Ces montants ne figurent pas dans les statistiques produites, bien qu'ils aient été repris dans le rapport d'activité 2018.

²⁵ Jusqu'au 2 juillet 2025, les récupérations d'indemnités sont déjà passées à 4.350.267,24 pour 65 dossiers. S'y ajoutent encore 359.550,44 euros de frais de justice pour 153 dossiers et 218.588,27 euros d'honoraires divers pour 62 dossiers.

²⁶ Selon le Fonds, un délai de 4 à 7 ans s'écoule en moyenne entre le versement de l'indemnité et les remboursements par l'assureur et dépend de la procédure juridique entamée (expertise, appel ou pourvoi en cassation). Le délai peut être plus long dans le cas d'un pourvoi en cassation.

Recommandation 7

Faire rapport de manière plus régulière et accessible au comité de gestion sur l'évolution des données essentielles concernant les avis, les indemnités, les expertises et les litiges

Fonds



Chaque année, le Fonds organise au moins quatre réunions ordinaires pour le comité de gestion et au moins une session d'information axée sur une thématique. En 2024, le fonctionnement du Fonds a ainsi été expliqué aux nouveaux membres du comité de gestion. La session d'information de 2025 portait, elle, sur la phase d'indemnisation. Entre ces réunions, des consultations ont également lieu par écrit.

Les rapports du comité de gestion de novembre 2023 à octobre 2024 démontrent que les membres suivent de près la situation financière du Fonds et l'état d'avancement des dossiers, et plus particulièrement l'évolution des délais de traitement. Dans ce cadre, le comité de gestion a toutefois demandé de recevoir des chiffres plus régulièrement pour ne pas attendre sa réunion suivante. Il a également demandé d'obtenir des informations concernant les obligations financières futures du Fonds pour les dommages graves lors de la confection et du suivi du budget. Cette dernière demande a entre-temps été mise en œuvre (voir la [recommandation 5](#)).

La recommandation est considérée comme mise en œuvre.

Recommandation 8

En cas de paiement de rentes ou d'avances, constituer des réserves pour les obligations financières futures et veiller à payer les honoraires des experts en temps voulu

Fonds
Inami

Le Fonds indique que le paiement des honoraires des experts ne connaît plus de retard depuis la désignation d'un comptable. Un secrétaire est formé pour assurer la continuité du service en l'absence du comptable. De nouvelles procédures sont à développer pour constituer des provisions pour les obligations futures. La recommandation est donc en cours de mise en œuvre.

Recommandation 9

Étayer les futures initiatives en matière d'informatisation par un examen des autres solutions éventuelles et une analyse des coûts et bénéfices et les mettre si possible en concordance avec l'approche globale de l'Inami

Fonds
Inami

Le Fonds utilise deux applications importantes dans la gestion de ses processus. D'une part, Damo pour la gestion des différentes phases²⁷ dans le traitement d'une demande d'une victime ou d'un ayant droit et, d'autre part, Eunom-e pour la gestion des litiges²⁸. Les différentes notes de mises à jour que le Fonds a transmises à la Cour des comptes et les rapports concernant les réunions TIC bimensuelles (voir ci-dessous) montrent que ces applications sont améliorées systématiquement.

²⁷ Le Fonds divise le traitement d'un dossier en trois phases. La première phase vise à vérifier si la demande remplit les conditions légales pour être prise en considération en vue d'un avis. Elle détermine en d'autres termes si la demande est « recevable sur le plan administratif ». Pour les demandes recevables, un avis sur le caractère « indemnisable » de l'accident est émis, lors de la deuxième phase, à la lumière d'un examen médical et juridique. En cas d'indemnisation, l'assureur du prestataire de soins est contacté ou une « offre d'indemnisation » est élaborée au cours d'une troisième phase.

²⁸ De plus, la plate-forme Tresorit est encore utilisée pour l'échange de pièces médicales avec les prestataires de soins.

Ainsi, le processus de l'indemnisation (phase 3) a notamment été intégré dans Damo en octobre 2024. Étant donné que ces développements sont effectués par le personnel TIC de l'Inami, une approche globale au sein de l'Inami est en principe garantie. L'application Eunom-e est dès lors aussi utilisée par les autres services de l'Inami, ce qui est efficient en termes de coûts. Le Fonds a en outre démontré que les investissements importants sont soumis à une analyse coût-bénéfice. La Cour des comptes considère donc cette recommandation comme mise en œuvre.

Recommandation 10

Compléter le système de gestion informatisé Damo, essentiellement pour qu'il puisse servir d'instrument de mesure pour le traitement des dossiers (en accordant une attention particulière aux modules manquants concernant le traitement des dommages)

Fonds
Inami



L'intégration dans Damo de la phase 3 (processus d'indemnisation) en octobre 2024 devrait permettre de suivre automatiquement certains délais et tâches. Les offres d'indemnisation sont ainsi relues par un juriste expérimenté, le coordinateur juridique et le directeur. En marge de cette évolution positive, la Cour des comptes remarque toutefois que les litiges sont nécessairement gérés dans l'application spécifique Eunom-e et qu'il n'y a pas encore de gestionnaire de données pour suivre de manière adéquate les processus (et la qualité des données). Néanmoins, cette recommandation peut être considérée comme mise en œuvre.

Recommandation 11

Aider à garantir la fiabilité des fichiers de données grâce à un contrôle, une formation, des manuels ou des instructions et impliquer davantage le personnel dans le développement des applications d'exploitation des données

Fonds
Inami



Le Fonds indique qu'il ne dispose toujours pas d'un bureau de gestion des données (*data office*) ni d'un entrepôt de données. Il est toutefois prévu de recruter un gestionnaire de données qui pourrait donner une impulsion à leur mise en place et en principe également veiller à la qualité des fichiers de données.

Le développement d'applications est suivi toutes les deux semaines lors d'une réunion TIC à laquelle participent des représentants du Fonds (le directeur et les coordinateurs médicaux et juridiques) et de l'Inami (les responsables TIC). Les collaborateurs du Fonds sont également activement impliqués dans le développement d'applications (notamment pour la mise en œuvre de tests). Lorsque des applications, nouvelles ou modifiées, sont intégrées dans Damo, une note de mise à jour reprenant un récapitulatif des adaptations est également publiée et les manuels sont adaptés. Des formations seraient également organisées en cas de développements plus conséquents.

Dans son audit, la Cour des comptes avait constaté que de nombreuses données ou étapes devaient encore être tenues à jour manuellement, par exemple pour l'indemnisation des victimes (phase 3). Il est difficile de déterminer si les mises à jour systématiques de nouvelles versions de Damo offrent une réponse suffisante à ce manquement. Ainsi, l'intégration de la phase 3 dans Damo n'a commencé que fin 2024 et la gestion des litiges se déroule dans l'application spécifique Eunom-e. La Cour des comptes signale que le manuel des processus du Fonds mentionne aussi certains cas où les collaborateurs doivent mettre en place leur propre système pour suivre certaines étapes²⁹.

²⁹ Le gestionnaire de dossiers est par exemple invité à mettre en place son propre système pour la rédaction d'une lettre de rappel afin de compléter le dossier administratif ou le clôturer lorsqu'une réponse fait défaut.

À la lumière de ces évolutions, la Cour des comptes estime que cette recommandation est encore en cours de mise en œuvre.

Recommandation 12

Traiter les demandes d'intervention de manière plus efficace, concernant tant les exigences formelles à respecter que le mode de communication avec le demandeur et le délai nécessaire

Fonds



Le Fonds signale différentes évolutions qui indiquent une amélioration des procédures. Ainsi, les demandeurs peuvent introduire leur demande auprès du Fonds (avec les documents nécessaires en annexe) et se renseigner sur le statut de leur dossier par voie électronique. Un groupe de travail évalue aussi le formulaire de demande afin de le rendre plus clair pour les demandeurs et d'éviter les problèmes par la suite.

Le modèle de décision a également été amélioré : seule une analyse médicale interne est effectuée pour certains dossiers recevables (voir la [recommandation 18](#)). Cette amélioration et le recours à la task force ont entraîné une diminution considérable des délais de traitement pour une majorité de dossiers. Le Fonds souligne ainsi que 80 % des dossiers ouverts en 2022 ont été clôturés après 13,2 mois, tandis que ce délai était encore de 23,5 mois pour les dossiers ouverts en 2020.

Entre la création d'un dossier et l'avis, le Fonds indique un délai de traitement moyen de 1.180 jours fin août 2025³⁰ contre 1.350 jours au pic relevé au cours de la période entre juin et août 2021. Le gain de temps le plus important concernerait les délais de traitement de la demande et de la réception d'informations médicales une fois le dossier déclaré administrativement recevable. Or, les chiffres avancés par le Fonds correspondent à peu près à ceux du rapport d'audit de la Cour des comptes³¹. En effet, le Fonds traitait alors un nombre encore relativement élevé de dossiers qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un avis, ce qui n'a fait qu'augmenter le délai de traitement moyen après 2018. Ce n'est qu'en septembre 2021 que la moyenne a entamé une nouvelle diminution.

Une attention doit être portée aux délais de traitement pour l'organisation et la réalisation des expertises unilatérales et contradictoires, qui s'élèvent en moyenne à 223 et 430 jours respectivement fin août 2025 (voir la [recommandation 18](#)). Bien que les délais de traitement soient inévitablement longs pour certains dossiers très complexes, il faudra fournir les efforts nécessaires pour les rendre acceptables. Des objectifs concrets doivent encore être fixés en la matière. Enfin, le monitoring des délais de traitement doit se poursuivre après la phase d'avis. En effet, l'indemnisation des victimes (phase 3) doit aussi faire l'objet d'un suivi satisfaisant. La Cour des comptes estime dès lors que cette recommandation est encore en cours de mise en œuvre.

Recommandation 13

Décider si les règles de priorité actuelles pour certains dossiers sont suffisamment justifiées et opportunes, notamment à la lumière de l'incidence d'une telle mesure sur les délais de traitement

Fonds



Le Fonds traitait généralement les dossiers selon le principe *first in, first out*, à la nuance près que le rythme de traitement de chaque dossier variait en fonction des étapes à suivre. Au fil des ans, il est toutefois devenu nécessaire de donner la priorité à certains dossiers, surtout à cause du retard lors du traitement des demandes.

³⁰ Pour tous les dossiers à partir de leur création qui n'ont pas été clôturés prématurément jusqu'à la date de l'avis.

³¹ La Cour des comptes a ainsi calculé un délai de traitement moyen de 1.166 jours, ou 38 mois, pour les avis clôturés entre 2013 et 2018. Pour les avis clôturés en 2018, le délai s'élevait à 1.416 jours (ou 46,5 mois).

Il avait ainsi été jugé opportun d'accélérer la procédure d'avis pour les dossiers « lourds », alors que le statut d'un dossier peut toutefois changer au cours de la procédure en fonction des informations obtenues. Dans ces dossiers, le seuil de gravité était atteint et les dommages avaient des répercussions particulières sur la famille (victime mineure, victime active économiquement avant les faits et en incapacité de travail totale depuis plus d'un an en raison de l'accident médical, victime décédée, etc.).

Cette procédure urgente existe encore, mais le Fonds l'applique moins fréquemment. Fin 2024, le Fonds traitait encore 49 dossiers lourds, qui représentaient 5 % des dossiers encore ouverts à l'époque, et en avait clôturé 191. En août 2025, le Fonds faisait encore état de 10 dossiers lourds. Il indique évaluer en permanence le système. Ce régime continue donc à exister, mais la nécessité d'y avoir recours diminue, notamment par l'amélioration générale des délais de traitement. Au vu du recours justifié à ce régime, la Cour des comptes estime cette recommandation mise en œuvre.

Recommandation 14

Dans la procédure de demande, souligner explicitement l'importance de l'assistance, d'autant plus qu'une victime peut en général toujours y prétendre (par exemple, auprès d'une mutuelle ou dans le cadre d'une assurance familiale)

Fonds



Comme les demandeurs peuvent introduire facilement une demande auprès du Fonds, l'accent est mis sur une communication proactive pour éviter que le Fonds ne doive traiter des demandes qui n'aboutiront pas ou seront déclarées irrecevables. Cette communication passe par différents canaux et contient des informations sur les conditions à remplir pour soumettre une demande, sur la compétence du Fonds ainsi que sur l'assistance pouvant être fournie dans le cadre de la demande³².

Ces informations figurent sur le site web de l'Inami, dans un dépliant « Quand pouvez-vous faire appel au Fonds des accidents médicaux ? » ainsi que dans le formulaire de demande (papier et électronique). Par ailleurs, le Fonds souligne également que ses collaborateurs sont disponibles pour répondre aux questions des demandeurs.

Enfin, le Fonds signale sa participation à des formations et webinaires lors desquels il présente son fonctionnement à des médecins et des avocats ainsi qu'à des débats avec les organismes assureurs ou d'autres organisations où il explique la loi relative aux accidents médicaux.

La Cour des comptes estime qu'il est primordial d'insister clairement dès l'introduction de la demande sur l'assistance disponible. Le groupe de travail chargé de réviser le formulaire de demande doit assurément en tenir compte. La Cour considère dès lors que la recommandation est en cours de mise en œuvre.

³² Cette assistance renvoie à la possibilité de désigner un mandataire (certaines mutualités, assurances et protection juridique, associations de patients, avocats, etc.).

Recommandation 15

Réorganiser en profondeur le processus de sélection des informations nécessaires au sujet de l'accident et confier à des gestionnaires de dossiers formés spécifiquement à cet effet la tâche de demander les données de base manquantes du dossier des patients

Fonds



Le rapport d'audit initial de la Cour des comptes indiquait qu'en 2018, il fallait attendre jusqu'à quinze mois en moyenne (465 jours) entre la date à laquelle le dossier était déclaré recevable sur le plan administratif et celle à laquelle le gestionnaire du dossier était invité à demander des informations médicales. Un gestionnaire de dossiers mettait ensuite près de trois semaines en moyenne (19 jours) pour envoyer cette demande.

Selon de nouveaux chiffres du Fonds, ces délais de traitement auraient diminué en 2024³³ pour atteindre respectivement 18 et 5 jours. Cette évolution positive résulterait de l'amélioration des procédures pour obtenir des informations médicales dès l'introduction d'une demande. Les gestionnaires de dossiers ont également testé une autre solution, à savoir demander les dossiers médicaux au préalable. Elle a toutefois été abandonnée parce qu'il s'est avéré par la suite que les médecins devaient toujours demander des informations médicales et qu'en parallèle, le délai de traitement pour la méthode classique diminuait significativement. La Cour des comptes considère dès lors cette recommandation comme mise en œuvre.

Recommandation 16

Préciser en temps voulu et clairement la collaboration attendue des prestataires de soins et de leurs assureurs et intervenir dans les situations où l'obligation d'information légale n'est manifestement pas respectée

Fonds



Le Fonds tente non seulement d'obtenir des informations médicales dès l'introduction d'une demande pour pouvoir effectuer une première analyse médicale interne plus rapidement, mais indique également avoir optimisé la procédure de contact avec les prestataires de soins. Ainsi, une liste d'adresses d'hôpitaux et de médecins-chefs est tenue à jour et une plate-forme sécurisée (Tresorit) permet de transmettre des dossiers médicaux électroniquement. Depuis 2019, le délai pour obtenir les informations médicales aurait diminué de plus de 50 % selon les chiffres du Fonds (passant de 85,2 jours en 2019 à 31 jours en 2024). Le Fonds n'a pas donné détaillé l'utilisation de la plate-forme ni explicité la mesure dans laquelle les prestataires de soins sont sanctionnés³⁴ si les informations médicales ne sont pas communiquées.

En outre, le Fonds souligne la responsabilisation des organismes assureurs (mutualités). Un paramètre a été ajouté dans le système des frais d'administration variables pour sanctionner le dépassement du temps de réponse acceptable.

Le Fonds indique que la collaboration avec les organismes assureurs se déroule bien, notamment grâce à la présence de leurs représentants lors d'une réunion annuelle, et qu'il engage rarement

³³ Mesurés pour tous les dossiers déclarés recevables sur le plan administratif et ayant fait l'objet d'une demande d'informations médicales en 2024.

³⁴ Si un prestataire de soins ne donne pas suite au rappel d'une demande d'informations dans un délai d'un mois, il doit verser au Fonds une indemnité forfaitaire de 500 euros par jour de retard (voir l'article 15 de la loi relative aux accidents médicaux). Ce montant de 500 euros est indexé annuellement. Lors de la clôture de l'audit initial de la Cour, le Fonds n'avait appliqué cette sanction qu'une seule fois. Celle-ci a été infligée en 2016, certes pour le maximum de 30 jours (15.224 euros).

une procédure contre un organisme assureur. Le Fonds n'a pas donné d'autres explications concernant l'amélioration de la collaboration avec les assureurs ni l'optimisation et l'application de sanctions éventuelles³⁵.

La Cour des comptes estime donc que les procédures internes ont été adaptées et ont permis d'améliorer la communication d'informations. La responsabilisation repose toutefois principalement sur les organismes assureurs (mutualités). La recommandation est considérée comme en cours de mise en œuvre.

Recommandation 17

Éviter que des demandes visiblement non fondées ne parcourent toute la procédure, mais donner suffisamment l'occasion à la victime de prendre position à ce sujet

Fonds



Dans son rapport initial, la Cour des comptes avait pointé une accélération possible des procédures au niveau du traitement des déclarations manifestement non fondées dans le cadre des contrats d'assurance protection juridique³⁶. Le Fonds estimait cette solution inconciliable avec l'obligation d'enquête du Fonds et de l'Inami en tant qu'organisme public, étant donné les devoirs et les tâches spécifiques qui y sont liés, ainsi qu'avec la gestion à assumer par le Fonds en la matière. Dans l'évaluation du traitement des déclarations manifestement non fondées, il ne voit aucun rôle spécifique confié aux gestionnaires de dossiers.

Le Fonds a toutefois prévu une accélération de la procédure permettant de clôturer le dossier sur la base d'une analyse médicale interne (décision Amic) en cas de demande potentiellement non fondée (voir la recommandation 18). Les demandes pourraient être déclarées comme non fondées plus rapidement étant donné qu'un minimum de documents médicaux doivent déjà être joints à la demande et que, selon le Fonds, il faut moins de jours pour introduire une demande pour obtenir de la documentation médicale (supplémentaire) (voir la recommandation 15). La Cour des comptes ne dispose pas de données pour confirmer cette information. Néanmoins, la Cour peut se rallier au point de vue et à la méthode de travail du Fonds.

Dans sa réponse, le Fonds renvoie ensuite aussi aux procédures internes dans le cas où le demandeur souhaite contester l'avis négatif du Fonds. Ainsi, si une nouvelle preuve concluante est communiquée, une expertise pourrait être demandée ou une concertation médico-juridique pourrait être organisée.

La Cour des comptes considère dès lors cette recommandation comme mise en œuvre.

³⁵ Aux termes de l'article 31 de la loi relative aux accidents médicaux, l'assureur est redevable d'une indemnité forfaitaire, pour autant que l'offre de l'assureur était manifestement insuffisante.

³⁶ L'assureur peut refuser de lancer une procédure judiciaire s'il n'existe pas ou manifestement pas suffisamment d'indications d'une éventuelle responsabilité. En contrepartie, le législateur a prévu que tout contrat d'assurance protection juridique doit comporter une clause garantissant à l'assuré le droit de consulter un avocat de son choix pour obtenir un avis au sujet d'un tel refus (clause dite d'objectivité). Si l'avocat confirme la position de l'assuré, l'assureur doit faire jouer sa garantie et rembourser la consultation intégralement. Si l'avocat confirme la position de l'assureur, l'assuré est remboursé de la moitié des frais et honoraires de la consultation.

Recommandation 18

Maintenir le choix opéré d'éviter les expertises externes ; en cas de dommage dépassant le seuil de gravité, organiser des expertises contradictoires uniquement si cela est vraiment nécessaire à la lumière de l'objectif de cette obligation légale

Fonds



Le Fonds a présenté un modèle décisionnel à la Cour des comptes. Selon ce modèle, aucune expertise externe (sur pièces, unilatérale ou contradictoire) n'est requise et le dossier est clôturé sur la base du rapport final de l'analyse médicale interne dans les cas suivants :

- un accident médical qui s'avère sans lien avec une prestation de soins ;
- un accident médical sous le seuil de gravité, sans responsabilité ;
- un accident médical au-dessus du seuil de gravité, pour lequel la demande est considérée comme non fondée³⁷ ;
- un accident médical dû à un diagnostic erroné sans faute ou à un échec thérapeutique³⁸.

En cas d'accident médical avec responsabilité ou d'accident médical sans responsabilité au-dessus du seuil de gravité, des expertises externes sont toutefois prescrites³⁹. Pour les accidents au-dessus du seuil de gravité, l'article 17, § 2, de la loi relative aux accidents médicaux prévoit en outre que cette expertise est toujours contradictoire.

Dans son rapport d'audit de 2018⁴⁰, la Cour des comptes constatait déjà une augmentation du nombre d'avis établis sans expertise externe. Des chiffres récents du Fonds indiquent également une augmentation des analyses médicales internes sur l'ensemble des analyses médicales⁴¹, mais ces chiffres sont difficilement comparables à ceux soumis lors de l'audit. La Cour considère malgré tout cette recommandation comme mise en œuvre, avec certes une remarque importante. Elle constate en effet une augmentation substantielle des délais de traitement lors de l'organisation et l'exécution d'analyses externes. Alors que le Fonds faisait état d'un délai de traitement moyen de 252 jours au 13 février 2020 (189 jours pour des expertises unilatérales et 289 jours pour des expertises contradictoires), il indique que ce délai moyen serait passé à respectivement 366, 223 et 430 jours fin août 2025. Cette évolution négative doit être suivie de près. Il s'agit en effet de dossiers dans lesquels la probabilité de devoir verser une indemnité aux victimes ou aux proches est plus grande.

Recommandation 19

Délimiter davantage la mission de l'expert et vérifier s'il pourrait être utile de se mettre d'accord au préalable sur le caractère contraignant des constatations d'une expertise contradictoire

Fonds



Pour le premier volet de la recommandation, le Fonds renvoie à la standardisation des lettres de mission, qui décrivent en détail la mission de l'expert, et des lettres d'accompagnement, qui précisent ce qui est attendu. La Cour des comptes déduit en outre du procès-verbal du comité de gestion du 4 octobre 2024 que le Fonds introduira une grille d'évaluation interne dans les prochaines années pour offrir une solution au problème des experts qui fournissent un travail de moins bonne qualité ou manquent de respect aux victimes. Les problèmes ou plaintes seront rassemblés pour chaque expert afin d'agir plus rapidement au besoin.

³⁷ C'est le cas lorsqu'il n'existe pas assez d'indications factuelles d'une responsabilité potentielle ou de dommages anormaux.

³⁸ Un traitement qui ne produit pas les résultats escomptés.

³⁹ En cas de responsabilité sous le seuil de gravité, une expertise unilatérale est proposée.

⁴⁰ Cour des comptes, *Fonds des accidents médicaux – Organisation et fonctionnement*, rapport à la Chambre des représentants, graphique 4, p. 59, Bruxelles, juin 2020, [courdescomptes.be](https://www.courdescomptes.be).

⁴¹ Le 18 octobre 2024, les analyses médicales internes concernaient 22,25 % des dossiers ouverts en 2023. Pour les dossiers ouverts en 2024, ce pourcentage était déjà passé à 29,39 %.

Le Fonds indique que les expertises contradictoires et les avis ne sont pas contraignants ni pour le demandeur, les prestataires de soins et leurs assureurs ni pour le juge. Il ne voit pas comment il pourrait rendre contractuellement contraignantes les conclusions d'un rapport d'experts pour les parties. En outre, le Fonds désigne l'expert à partir d'une liste d'experts sélectionnés sur la base d'une procédure d'adjudication publique⁴². Il n'est donc pas toujours possible de nommer des experts sur lesquels s'accordent les parties.

La recommandation est dès lors considérée comme mise en œuvre.

Recommandation 20

Dans le volet juridique des avis, veiller à la cohérence et à la pertinence des sources et des explications fournies et à utiliser une formulation compréhensible pour tous les intéressés

Fonds



Le Fonds peut rendre deux types d'avis :

- des avis longs (accidents médicaux avec responsabilité ou accidents médicaux sans responsabilité au-dessus du seuil de gravité) ;
- des avis courts (accidents médicaux sans responsabilité sous le seuil de gravité ou dossiers irrecevables, comme ceux qui ne concernent pas une prestation médicale).

Lors de l'élaboration des modèles d'avis, le Fonds est attentif à la pertinence des informations fournies. Dans les avis longs, la notion complexe de « dommage anormal » n'est ainsi plus détaillée en cas d'accident médical avec responsabilité. Si la responsabilité n'est pas établie, le lien de causalité entre le dommage et l'absence de faute n'est plus explicité. Les avis concernant des accidents médicaux avec responsabilité sont également accompagnés d'une lettre d'introduction comprenant une synthèse en langage accessible. Concernant les avis courts aussi, seules les informations pertinentes sont désormais commentées. Le Fonds ne joint un rapport médical interne détaillé que dans des cas exceptionnels, par exemple pour expliquer pourquoi le Fonds n'adhère pas à l'opinion de l'expert.

Dans le cadre de cette adaptation, le Fonds indique que la cohérence et la pertinence des sources sont également prises en considération et que le renvoi aux sources les plus récentes est restreint. Le jargon technique serait aussi limité au strict minimum (comme l'utilisation de termes latins). Pourtant, le jargon reste une exigence nécessaire parce que les avis représentent la position juridique du Fonds et constituent la base de la justification en cas de litige.

En ce qui concerne les possibilités de recours pour les demandeurs, le Fonds note que la législation a été adaptée entre-temps, de sorte qu'un demandeur est désormais en mesure d'interpréter clairement les possibilités de recours contre l'avis obtenu. Il est ainsi signalé que le demandeur dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de l'avis pour introduire un recours contre la décision du Fonds. Pour les actions en responsabilité civile contre le prestataire de soins ou son assureur, il est toujours renvoyé aux délais de prescription fixés en droit commun.

La Cour des comptes considère que cette recommandation est mise en œuvre.

⁴² Début 2025, une nouvelle adjudication publique a été lancée pour la désignation d'experts médicaux.

Recommandation 21

Élaborer des directives accompagnées d'exemples pratiques suffisants concernant le calcul, le mode de paiement et le caractère résiduaire des indemnités dues par le Fonds ; faire éventuellement appel à une aide extérieure dans la phase de lancement

Fonds



Le Fonds a transmis à la Cour des comptes un manuel récent expliquant les différentes étapes de la procédure de la phase 3 à parcourir jusqu'à soumettre une offre d'indemnisation aux juristes. Cette phase a également été intégrée dans Damo en octobre 2024. La gestion des litiges est toutefois maintenue dans une autre application (Eunom-e). Cette séparation répond à la demande de l'Inami, qui souhaite que tous les litiges soient gérés dans cette application.

Pour l'indemnisation des dommages corporels, le Fonds a rédigé des directives, destinées à décrire clairement les dommages potentiels et à détailler leur interprétation. Les différents éléments des dommages (frais médicaux, incapacité temporaire, dommage permanent, décès) et la méthode d'indemnisation (forfait, capital ou rente) sont ainsi expliqués. Les interventions d'autres entités sont également prises en considération et déduites de l'indemnité. Il s'agit notamment de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne (mutualités), du budget de soins pour les personnes en situation de grande dépendance de la protection sociale flamande (*Vlaamse Sociale Bescherming*), d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration (Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité sociale) et de l'allocation familiale majorée.

La liste devra toutefois encore être complétée. Les éventuelles indemnités versées par l'agence flamande pour les personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) devront par exemple aussi être prises en considération. Des accords devront éventuellement être conclus pour échanger les informations et éviter les doubles indemnités⁴³. Le Fonds a, depuis, fait part de son souhait de poursuivre ses efforts de négociation avec d'autres entités intervenant dans le paiement de l'indemnité.

Enfin, le Fonds a également signalé l'organisation d'ateliers sous la direction du coordinateur juridique sur différents sujets concernant le calcul de l'indemnité.

Le Fonds a donné une suite positive à la recommandation d'élaborer des directives. Toutefois, étant donné qu'il faut encore tenir compte des indemnités que versent d'autres entités, la Cour des comptes considère cette recommandation comme en cours de mise en œuvre.

Recommandation 22

Demander au comité de gestion de clarifier les questions de principe au sujet de l'application de la loi ; utiliser le fait que cette interprétation est cautionnée par les parties prenantes comme argument en cas de discussion ou de litige

Fonds



Le Fonds renvoie en premier lieu aux directives internes qui doivent garantir une interprétation uniforme de la réglementation et la formulation de points de vue.

- Les collaborateurs disposent de directives, qui sont adaptées si nécessaire.
- Les coordinateurs organisent des ateliers pour expliquer les concepts et positions du Fonds.
- Il est demandé aux avocats et médecins représentant le Fonds dans les dossiers (notamment dans le cadre de litiges) de vérifier la jurisprudence et l'existence de décisions antérieures du Fonds dans les bases de données.

⁴³ Un protocole de partage d'informations a été conclu avec la Direction générale (DG) des personnes handicapées en novembre 2024. Le Fonds peut ainsi tenir compte des indemnités versées par la DG.

En outre, le Fonds renvoie à une analyse de la réglementation existante, qui devrait être approfondie et soumise au comité de gestion. À cet effet, le recrutement d'un expert juridique était prévu, mais n'a pas pu avoir lieu (voir la [recommandation 4](#)). Un inventaire non exhaustif des modifications possibles a provisoirement été créé. Dans le cadre du prochain contrat d'administration de l'Inami, un groupe de travail devrait soumettre au comité de gestion du Fonds une liste précise des modifications nécessaires d'ici le 31 décembre 2026 ainsi que ses résultats d'ici le 28 février 2027. Dix mois après sa validation par le comité de gestion, le nouveau cadre réglementaire devrait être élaboré.

Reste à voir dans quelle mesure le comité de gestion adoptera des positions claires sur ces modifications législatives, de même que sur les problèmes mis en lumière par la Cour des comptes dans son rapport d'audit initial. Elle avait ainsi constaté par exemple que le Fonds n'est pas en mesure de se prononcer sur la couverture d'assurance d'un prestataire de soins ou la suffisance d'une indemnité proposée par le prestataire de soins ou son assureur⁴⁴. La Cour considère dès lors cette recommandation comme en cours de mise en œuvre.

Recommandation 23

Compléter le plan de communication par un volet sur la gestion des dossiers et la correspondance y relative et par un volet sur l'information demandée par la loi au sujet de la politique appliquée lors des avis rendus

Fonds



Le Fonds indique que sa communication avec les demandeurs a évolué sur différents plans.

- Une demande peut désormais aussi être introduite et suivie par voie électronique⁴⁵.
- Différentes lettres ont été adaptées. Le délai indicatif de 6 mois a été supprimé dans la lettre qui confirme la recevabilité de la demande.
- Le Fonds établit une distinction entre les avis longs et les avis courts, évite le vocabulaire technique et indique désormais explicitement les délais de recours (voir la [recommandation 20](#)).

En outre, le Fonds a renvoyé au rapport d'activité annuel, qui devrait encore être adapté à l'avenir. La collaboration d'un gestionnaire de données a toutefois déjà été demandée pour cette adaptation. En ce qui concerne la poursuite du développement de sa mission de prévention⁴⁶, le Fonds a souligné ses limitations pour mener des études pertinentes, le fait qu'il ne traite chaque année qu'un nombre limité de dossiers⁴⁷ et la priorité donnée au traitement des dossiers. Par conséquent, la Cour des comptes considère cette recommandation comme en cours de mise en œuvre.

⁴⁴ En principe, le Fonds n'a pas connaissance des offres d'indemnisation convenues entre la victime et le prestataire de soins ou son assureur. De même, il ne suit pas les dossiers d'accidents médicaux avec responsabilité sous le seuil de gravité.

⁴⁵ Cette possibilité a été introduite sur la base de l'article 119 de la loi du 18 mai 2022 portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé. Entre mars 2024 et octobre 2024, 113 demandes (33,5 %) ont été communiquées au Fonds par voie électronique.

⁴⁶ Sur la base de l'article 8, § 2, de la loi relative aux accidents médicaux, le législateur a chargé le Fonds de formuler des recommandations en matière de prévention ou de réparation des dommages résultant de soins de santé et, dans le prolongement de cette mission, de tenir à jour et d'analyser les données statistiques ou financières relatives aux accidents médicaux et aux indemnités accordées. Le Fonds doit également commenter les avis qu'il formule. Le Fonds rédige en outre chaque année un rapport d'activité à ce sujet.

⁴⁷ Le Fonds n'a pas connaissance du contenu des dossiers d'accidents médicaux réglés à l'amiable ou par décision judiciaire. Il ne peut donc donner qu'une image partielle de cette problématique.

Recommandation 24

Examiner les possibilités de régler à l'amiable les litiges avec les victimes et les prestataires de soins (et leur assureur) et élaborer les directives nécessaires ainsi qu'un cadre d'évaluation à cet effet

Fonds



Initialement, le Fonds avait indiqué qu'il mettrait au point des procédures de médiation avec les victimes, mais en se limitant aux dossiers d'indemnisation des accidents médicaux au-dessus du seuil de gravité, dans lesquels le Fonds intervient financièrement. Ces procédures permettraient des contacts plus fréquents avec les demandeurs d'indemnisation qui ne peuvent réagir qu'une seule fois à une offre d'indemnisation du Fonds dans la procédure actuelle, ce qui est jugé insuffisant.

Le Fonds avait également proposé d'examiner si une médiation pouvait être organisée entre le demandeur et le prestataire ou l'établissement de soins pour les dossiers où aucune responsabilité n'a été constatée. À la suite de la formation du nouveau gouvernement et des économies imposées, il a toutefois été décidé de donner la priorité à la gestion de dossiers individuels. La recommandation est donc considérée comme non mise en œuvre.

6 Conclusions

En 2019 et 2020, la Cour des comptes avait examiné l'organisation et le fonctionnement du Fonds et le degré de réalisation de ses objectifs 10 ans après sa création. La Cour avait constaté que peu de victimes faisaient appel au Fonds, principalement en raison des délais de traitement très longs et de la faible probabilité d'indemnisation. Elle avait également souligné la non-réalisation de missions et les frais de fonctionnement élevés du Fonds.

Cinq ans après la publication de son rapport initial, la Cour des comptes constate que l'adaptation du traitement des dossiers et l'intervention d'une task force spéciale ont permis de diminuer le retard dans le traitement des dossiers, ce qui influe également sur les délais de traitement. Le délai de traitement moyen jusqu'à l'avis connaît ainsi une nouvelle diminution ces dernières années. Le Fonds devra toutefois continuer à suivre attentivement ces deux aspects parce que le temps nécessaire aux expertises contradictoires affiche entre-temps une nouvelle hausse. En outre, un dossier ne s'arrête pas toujours à un avis. Le Fonds doit en effet aussi pouvoir verser une indemnité à temps. Des systèmes efficaces de suivi des dossiers ont été mis en place, mais doivent encore être étendus et affinés.

La clôture des travaux de la task force et l'échéance fin 2025 du contrat d'administration liant l'Inami à l'État offrent l'occasion au Fonds de réexaminer sa stratégie et ses plans opérationnels. Ces prochaines années, le Fonds continuera toutefois à se concentrer sur la gestion des dossiers individuels, l'amélioration de leur suivi et la révision de certaines dispositions dans la loi relative aux accidents médicaux. Néanmoins, il reste des missions que le Fonds n'a pas encore suffisamment menées à bien et le coût de son fonctionnement est toujours relativement élevé. La question subsiste dès lors de savoir s'il est utile que le Fonds rende un avis dans des dossiers où il n'intervient en principe pas financièrement. Le rôle du Fonds et ses missions pourraient dès lors être réexaminés lors de l'analyse prévue de la loi relative aux accidents médicaux.

Dans l'intervalle, le Fonds peut continuer à travailler à la mise en œuvre des recommandations du rapport initial de la Cour des comptes. Sur la base de son suivi, la Cour a en effet constaté que, sur les 24 recommandations formulées, 12 sont encore en cours d'exécution et 1 n'a pas été mise en œuvre. Elle considère 11 recommandations comme mises en œuvre.

Ce rapport est disponible uniquement en version électronique,
en français et en néerlandais, sur courdescomptes.be.



DÉPÔT LÉGAL

D/2025/1128/44

PHOTO DE COUVERTURE

Shutterstock

ADRESSE

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

TÉL.

+32 2 551 81 11

courdescomptes.be